

ТИББИЁТДА ҚЎЛЛАНИШИГА ДОИР ЙЎРИҚНОМАДАН КЎЧИРМА ОРИПЕН

Препаратнинг савдо номи: Орипен
Таъсир этувчи модда (ХПН): мебеверин
Дори шакли: таъсири узайтирилган капсулалар.
Таркиби. Фаол модда: мебеверин гидрохлорид 80% микрогранулалари (пеллетлари) 200 мг мебеверин гидрохлоридга эквивалент;
ёрдамчи моддалар: натрий лаурилсульфати, сувсиз династрия фосфати, лактоза, калций карбонати, маннитол, сахароза, ядро учун сахароза, гипромеллоза, shacryl 30D (ичакни қопловчи полимерлар), диэтилфталат, полисорбат 80, талк тозаланган, титан диоксиди, натрия гидрохлориди.

Фармакотерапевтик гуруҳи: Спазмолитик восита.

Фармакологик хусусиятлари

Таъсир механизми ва фармакодинамик самараси.

Миотроп таъсирга эга спазмолитик, ичакнинг нормал перистальтикасига таъсир қилмасдан спазмни йўқотиб, меъда-ичак йўллариининг силлиқ мушакларига бевосита таъсир кўрсатади. Бу самара вегетатив нерв тизими томонидан назорат қилинмаслиги туфайли, типик антихолинергик таъсири йўқ.

Фармакокинетикаси

Сўрилиши.
Ичга қабул қилиганидан кейин мебеверин тез ва тўлиқ сўрилади. Ажралиб чиқиши модификацияланган дори шакли кунига 2 марта дозалаш тартибини ишлатиш имконини беради.

Қўлланилиши

Катталар ва 10 ёшдан ошган болалар.

Оғрик, спазмлар, таъсирланган ичак синдроми билан боғлиқ бўлган дисфункциялар ва ичак сохасидаги дискомфортни симптоматик даволаш. Меъда-ичак йўллари аъзоларининг спазмларини даволаш. (шу жумладан органик касалликлар билан боғлиқ бўлган)

Қўллаш усули ва дозалари

Ичга қабул қилиш учун.

Капсулаларни етарли миқдордаги (100 мл дан кам бўлмаган) сув билан бирга қабул қилиш керак. Капсулаларни чайнаш мумкин эмас, чунки уларнинг қобиклари препаратни узоқ муддат ажралиб чиқишини таъминлайди.

Катталар ва 10 ёшдан ошган болалар.

Бир капсуладан суткада 2 марта, битта - эрталаб ва битта – кечкурун.

Препаратни қабул қилишнинг давомийлиги чекланмаган.

Агар бемор бир ёки бир неча дозаларни қабул қилишни унутган бўлса, қабул қилишни

навбатдаги дозадан давом эттириши керак. Одатдаги дозага қўшимча ўтказиб юборилган бир ёки бир неча дозаларни қабул қилмаслик керак.

Ножўя таъсирлари

Аллергик реакциялар асосан тери қопламлари томонидан кузатилган, лекин шунингдек аллергиянинг бошқа кўринишлари ҳам аниқланган.

Тери ва тери ости тўқималари томонидан:

эшакеми, ангионевротик шиш, юзнинг шиши, экзантема.

Иммун тизими томонидан бузилишлар: ўта юқори сезувчанлик реакциялари (анафилактик реакциялар).

Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар

Фаол моддага ёки препаратнинг ҳар қандай нофаол компонентларидан бирига ўта юқори сезувчанлик.

Ҳомиладорлик ва эмизish даври. 10 ёшгача бўлган болалар (ушбу дори шакли учун).

Дориларнинг ўзаро таъсири

Ушбу препаратни факат алкоголь билан ўзаро таъсирини ўрганиш бўйича текширувлар ўтказилган. Хайвонлардаги *in vitro* ва *in vivo* текширувлар мебеверин гидрохлориди ва этил спирти орасида ўзаро таъсир йўқ эканлиги аниқланган.

Дозани ошириб юборилиши

Доза ошириб юборилган ҳолда, назарий жихатдан, марказий нерв тизимининг кўзгалувчанлиги ошиши мумкин. Препаратнинг дозаси ошириб юборилган ҳолларда белгилар бўлмаган ёки ахамиятсиз даражада бўлган ва одатда, тез вақт ичида қайтувчи бўлган. Дозанинг ошириб юборилишининг аниқланган белгилар неврологик ва юрак, қон-томир характериға эга бўлган. Махсус антидоти номаълум. Симптоматик даволаш тавсия этилади. Агар препаратнинг бир неча дозалари қабул қилинганидан кейин тахминан бир соат давомида интоксикация аниқланган ҳолда меъдани ювиш керак. Сўрилишини пасайтириш бўйича чоралар талаб этилмайди.

Чиқарилиш шакли. 10 капсуладан контур-уяли ўрамда, 3 ёки 5 контур уяли ўрам қўллаш бўйича йўриқномаси билан бирга картон қутида.

Сақлаш шароити. Қуруқ, ёруғликдан ҳимояланган жойда, 25°C дан юқори бўлмаган ҳароратда сақлансин.

Болалар оломайдиган жойда сақлансин.

Яроқлилик муддати. 2 йил.

Яроқлилик муддати тугагандан сўнг қўлланилмасин.

Дорихоналардан бериш тартиби

Рецепт бўйича.

Рўйхатдан ўтказилганлик гувоҳномаси:

DV/M 04058/03/22

мебеверин 200мг

ОРИПЕН

30 та узоқ муддатли таъсир кўрсатувчи капсулалар



УЗОҚ МУДДАТЛИ ТАЪСИР КЎРСАТУВЧИ СПАЗМОЛИТИК ВОСИТА



Орипен ошқозон-ичак
тракти, ўт йўллари ва
ошқозон ости беzi
каналларининг силлиқ
мушакларига бевосита
таъсир клади



Одди сфинктерига
юқоритропикликка
эга, бу броплик
тизимли
антиспазмолитикларга
нисбатан 20 барабар
юқори.



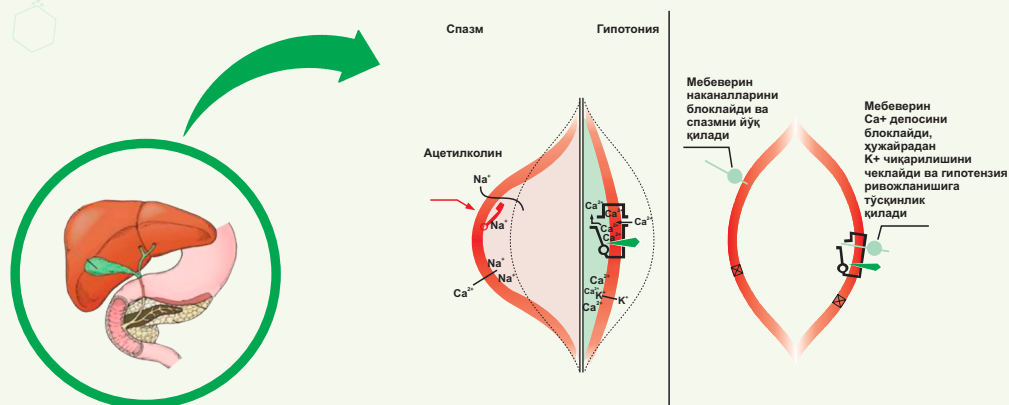
Ичак
атониясини
келтириб
чиқармасдан
спазмни
енгиллаштиради



ОРИПЕННИНГ АНТИХОЛИНЕРГИК ТАЪСИРИ ЙЎҚ



Мебевериннинг таъсир механизми



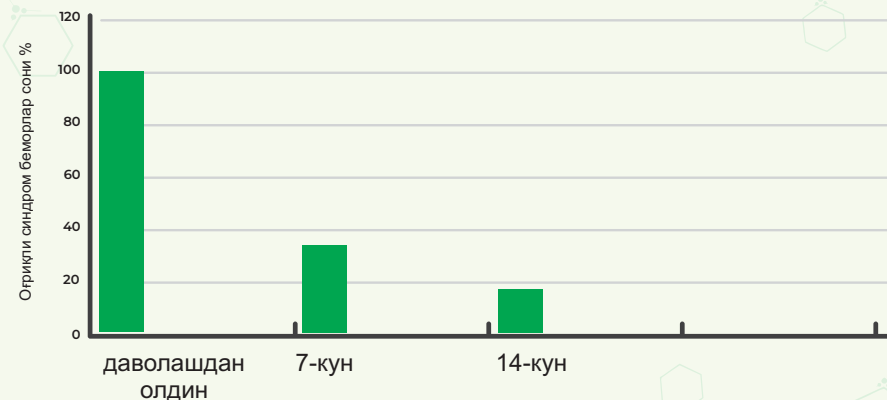
Мебеверин ошқозон-ичак моторикасини нормаллаштирувчи, яъни антиспазмолитик ва прокинетик таъсирларни бирлаштиради.

Антиспазмолитикларнинг қиёсий хусусиятлари

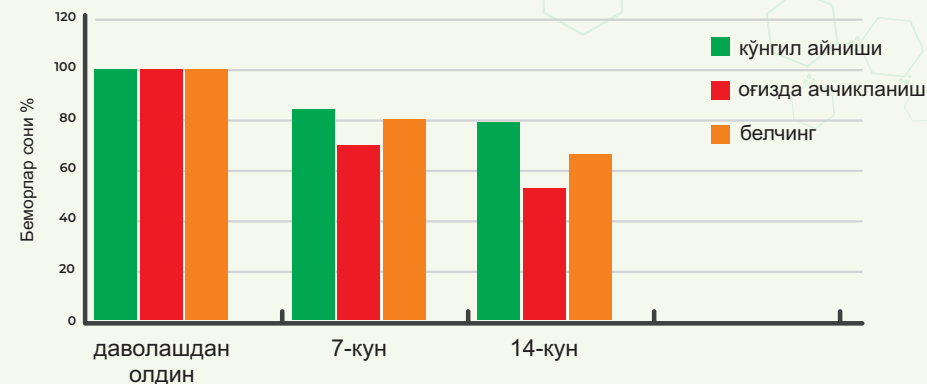
	Тизимли антиспазмолитиклар (М-холинолитиклар, дроговерин)	Селектив антиспазмолитиклар (мебеверин)
Ошқозон-ичак трактига селективлиги	Селектив эмас, ички органларнинг силлиқ мушакларининг тонусини пасайтиради, қон томирларини кенгайтиради	у фақат ошқозон-ичак трактининг силлиқ мушак хужайрасига таъсир қилади
Одди сфинктерига нисбатан тропиклик	Одди сфинктерига нисбатан селективлик мавжуд эмас	Одди сфинктерини бўшатиш қобилиятида Папавериндан 20 баравар самарали
Ножўя таъсирлари	юрак тез уриши, иссиқлик ҳисси, қон босимининг пасайиши, АВ блоккланиши, хира кўриш, бош айланиши, ичак атонияси, сийдик ажратишда кийинчилик	камдан кам, баъзи ҳолларда
Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар	Дори восита таркибий қисимларига гиперсезгирлик, глаукома, простата аденомаси, ҳомиладорлик	Препаратнинг алоҳида компонентларига юқори сезувчанлик

Мебеверинни юрак-қон томир касалликлари бўлган беморларни даволашда, глаукома ва простата аденомаси булган беморларни даволашда қўллаш мумкин.

Ут тош касаллиги булган беморларда оғриқ синдромининг динамикаси мебеверин 200мг билан монотерапияда кунига 2 марта қўлланганда



Ут тош касаллиги булган беморларда диспептик бузилишлар динамикаси мебеверин билан монотерапияда



Натижалар ва хулосалар

7 кунлик даволанишдан сўнг беморларнинг 70 фоизда ўнг коверга остида оғриқ камайди, ва 14 кундан кейин 85% бутунлай йўқолди. Диспептик касалликларни бартараф етишда ижобий динамика. Дуоденогастрик рефлюксни камайтириш шаклида ўртача прокинетик самарадорлик. Ултраровуш маълумотларига кўра, ўт пуфагининг кискариш функцияси унинг пасайиши билан яхшиланган.